

Kas toetatud elamise teenus toetab enesemääramisõigust?



Katrin Liiv, MA

Kolme teenusepakkuja juures toetatud elamise teenust kasutanud inimestelt uuriti, mil määral on teenus neil võimaldanud osaleda otsustusprotsessides, kuidas nad teevad otsuseid oma elu puudutavates küsimustes ning mõistavad enesemääramisõigusega seotud vajadusi. Uurimuse tulemused kinnitasid, et teenus peaks toetama inimeste autonoomiat, kompetentsust ja seotust, sest see aitab neil liikuda suurema iseseisvuse poole.

Psüühikahäirete ja vaimupuudega inimeste ühiskonda kaasamiseks on viimase 20 aasta jooksul rakendatud uusi lähenemisi. Üks neist on deinstitutionaliseerimine, mis tähendab kogukonnapõhiste teenuste eelistamist.

Tugiteenuseid kasutaval inimesel on, nagu kõigil teistelgi, õigus teha tuleviku-plaane ja kontrollida oma elu ja suhteid; tal on ka õigus teada oma võimalusi ja saada tuge just nende tegevuste juures, kus ta seda vajab. Enesemääramise teooria järgi on igal inimesel vaja tunda end iseseisva, pädeva ja seejuures teistega seotuna (Ryan ja Deci 2017, 3).

Järgnevalt tutvustan uurimust¹, milles küsisime toetatud elamise teenuse kasutajatelt, kuidas nad on kaasatud teenuseüksuse igapäevaellu ja kogukonda ning kas nad on muutunud iseseisvamaks. Selle kõrval selgitasime, kas need inimesed teadvustavad oma psühholoogilisi vajadusi ja kas teenus aitab neid rahuldada. Esmalt aga teenusest ning uurimuse teoreetilistest lähtekohtadest.

Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk on tagada abistatava inimese võimalikult iseseisev toimetulek, pakkudes talle individuaalset juhendamist (Sotsiaalkindlustusamet 2018). Selline toetus valmistab klienti ette elama kas väiksemat toetust saades või iseseisvalt. Vastavalt vajadustele koostatakse talle kohe isiklik tegevusplan. Toetus tähendab juhendamist majapidamistöodes, toiduvalmistamisel, sisseostude tegemisel, eelarve koostamisel, avalike teenustega seotud asjaajamisel ja kultuuriürituste külastamisel.

Euroopa Ekspertgrupi 2012. aastal koostatud dokumendi „Euroopa ühtsed juhised institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele süsteemile ülemineku kohta” järgi tuleb teenuse kasutajatele võimaldada kontrolli saadavate teenuste üle. Kvaliteetse teenuse tunnusteks on hajutatud eluase ehk elamine korteris või kodus, juurdepääs avalikele teenustele, isikukeskne toetus ja inimese osalemine otsustusprotsessides. (European Common Guidelines... 2012).

¹ Tallinna Ülikoolis 2018. a kevadel kaitstud magistritöö „Vaimse tervise teenused kogukonnas ja klientide kaasamine toetatud elamise teenuse näitel”, juhendajad Marju Medar ja Indrek Sooniste.

Teenusele suunatud inimesed võivad küll olla sarnase diagnoosiga, kuid nende abivajadus, arengu- ja õppimisvõime, soovid, suhtlemisoskus jms on erinevad. Kuigi teenus on sama, vajab iga klient personaalset lähenemist. Arengueesmäärke seades lähtutakse igapäevaste oskustest, võimetest ja elukeskkonnast.

Selle sihtrühmaga töötamine seab personali ette keerulise ülesande: tuleb tagada järelevalve, et hoolealune saaks vajadusel ravi ja osaleks sotsialiseerivates ja rehabilitatiivsetes tegevustes, kuid vaja on säilitada ka usalduslik suhe ja teha koostööd, pakudes tuge just sel moel, nagu abistatav seda soovib. Ainult inimese kõrval olles, väärtustades tema ainukordsust ja austades tema õigust ise valida ning leida viise, kuidas neid valikuid teostada, on võimalik mõista toetatud elamise teenuse tõelist mõtet. (O'Brien 1993)

Võrdsed võimalused kogukonnas elamiseks

Õigus elada kogukonnas tuleneb nii inimõigustest, kaasaegse poliitika suundadest kui ka tunnustatud teooriatest.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 19 sätestab, et neil inimestel on võrdselt teistega õigus elada kogukonnas ning omada teistega võrdsed valikuvõimalusi. Konventsiooni järgi on riigil kohustus välja töötada elukohajärgsed ja kogukondlikud tugiteenused.

Eespool juba osundatud Euroopa Ekspertgrupi 2012. aasta dokumendis tuuakse välja, et inimesed peavad saama ise otsustada nende elu puudutavate küsimuste üle. Igal inimesel, sõltumata tema erivajadustest peab olema võimalik elada iseseisvat ja normaalset elu kodusarnastes tingimustes.

Enesemääramise teooria kohaselt tunneb

inimene end oma elukohas või kogukonnas kaasatuna, kui ta saab seal proovida oma oskusi ja pädevusi, ise algatada tegevusi ning neid ellu viia (Ryan ja Deci 2017, 82)

Enesemääramise teooria kohaselt tunneb inimene end oma elukohas või kogukonnas kaasatuna, kui ta saab seal proovida oma oskusi ja pädevusi, ise algatada tegevusi ning neid ellu viia.

Normalisatsiooni teooria järgi paraneb inimese elukvaliteet siis, kui tal on ligipääs kõigile tegevustele, mida peetakse ühiskonna argielu osadeks: ta saab kasutada avalikke teenuseid, osaleda kultuuriüritustel, olla kaasatud otsustamisse, olla aktsepteeritud sellisena nagu ta on loodud (Landesman ja Butterfield 1987). Selle teooria pooldajad peavad kõiki suuri hooldusasutusi inimväärlikust alandavateks, samas märgivad nende vastased, et kui need asutused sulgeda ja tuua inimesed elama kogukonda, siis ei tähenda see, et seal oleks neile alati tagatud vajalik tugi (Dixon jt 2004).

Kui hoolekandenasutuses elanud inimene jääb sealt välja tooduna ilma vajalikust hooldest, kaitsest, ravist ja kohandatud keskkonnast, siis tema elukvaliteet ei parane. Kui aga inimesi hästi ette valmistada, õpetades neid kasutama toetavaid avalikke teenuseid, siis kogevad nad kogukonda turvalise ja kaitstud elukeskkonnana. (Roos jt 2017).

Enesemääramisõigusega seotud vajadused

Enesemääramise teooria kohaselt saab iga inimene kujundada oma käitumist oma sisemiste ressursside abil. On võimalik ka hinnata, kuidas bioloogilised, sotsiaalsed ja kultuurilised tingimused toetavad või õõnestavad inimese loomumaseid

psühholoogilisi ressursse nii üldiselt kui ka kindlates valdkondades ja tegevustes. Inimese kolm psühholoogilist põhivajadust on autonoomia, kompetentsus ja seotus. Teooria autorid Ryan ja Deci (2000) väidavad, et need tunnetatud vajadused on inimese motivatsiooni alustalad.

Autonoomia tähendab suutlikkust iseseisvalt määrata oma elukäiku ja eelkõige oma käitumist ning selle eest vastutada.

Kompetentsus on rahulolu oma oskuste, võimete ja tunnetega, mis on seotud jõukohaste tegevustega, millega inimene hästi toime tuleb. Kui inimene tunneb end kompetentsena, siis tahab ta vastava asjaga tegeleda parema meelega.

Seotus tähendab olukorda, kus inimene tunneb kokkukuuluvust teiste inimeste või kogukonnaga, milles ta igapäevaselt toimetab. Igäihel on loomumane vajadus olla väärtustatud, aktsepteeritud ja kuhugi kuuluda.

Igal inimesel on talle ainuomased vajadused, mis peavad olema täidetud, et saavutada heaolu ja terviklikkus. Nende puudulik

rahuldatus või häirumine teeb suurt psüühilist kahju. (Ryan ja Deci 2000).

Enesemääramise teooriale tuginedes võib väita, et kui teenust saaval inimesel on need kolm põhivajadust täidetud, siis on tal lihtsam tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena, säilitada kontroll oma elu üle ja saavutada võimetekohane iseseisvus.

Uurimuse korraldus

Intervjueerisime toetatud elamise teenust kasutanud inimesi. Mõnikord olid küsitlemise juures ka tegevusjuhendajad. Tahtsime küsitleda 16 klienti neljas teenuseüksuses, kuid valimiks kujunes lõpuks siiski üheksa intervjueeritavat, kes kasutasid kolme teenusepakkuja toetust Eesti eri paikades (vt tabel 1).

Tahtsime teada:

- Mil määral toetatud elamise teenus võimaldab kasutajate osalemist otsustusprotsessides?
- Kuidas teevad vastajad otsused oma elu puudutavates küsimustes?

Tabel 1. Uurimuses osalejad

vanus	sugu	Elas enne asutuses	Elamispinna omandisuhe (I-isiklik, TP-teenusepakkuja omandis)	Teenuseüksuses teenusel oldud aeg
27	N	ei	TP	3 aastat
27	N	ei	TP	1 aasta
30	N	ei	I	4 kuud
30	N	ei	TP	2 aastat
21	M	ei	I	2 aastat
26	M	ei	TP	6 kuud
43	M	jah	TP	8 kuud
52	M	jah	TP	8 kuud
54	M	jah	TP	2 aastat

- Kuidas nad mõistavad autonoomiat ja kompetentsust enda abivajadust kompenseeriva tegevuse planeerimisel?

Kvalitatiivne uurimisstrateegia võimaldas vastajatel kirjeldada oma kogemusi enda võimeid arvestades. Poolstruktureeritud intervjuu küsimuste koostamisel võtsime aluseks Euroopa Ekspertühma dokumendi „Euroopa ühtsed juhised institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele süsteemile ülemineku kohta”. Intervjuu 23 avatud ja suunatud küsimust puudutasid vastaja valikuid, otsuseid, tegevusi, avalike teenuste kasutamist ja elutingimusi.

Andmeid kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil analüüsides hindasime, kuivõrd on teenust kasutanud inimesed teadlikud enesemääramisõigusest ning kas nende puhul on täidetud autonoomia, kompetentsuse ja seotuse vajadus.

Uurimistulemused

Teadlikkus enesemääramisõigusest ja sellega arvestamine. Tulemusi analüüsides selgus, et vähesed toetatud elamise teenusel olevad inimesed teadvustavad enesemääramise õigust ja sellega kaasnevaid võimalusi oma elu planeerimisel. Eriti paistab see silma nende puhul, kes on pidanud vahe-tama teenuseüksust. Teenuseüksused, kus lähtutakse CARE meetodikast, arvestavad klientide enesemääramise teooriast tulenevate põhivajadustega rohkem ja see kajastub ka intervjueritute vastustes.

Autonoomia. Inimesele on tähtis tunda, et ta suudab tegevusi ise algatada ja nende eest vastutada (Ryan ja Deci 2017, 97). Vastustest selgus, et teenus toetab autonoomiat. Vastajad kasutasid tihti sõna „iseseisvus” ning tõid välja, et nad väärtustavad suuremat iseseisvust, mida teenus

võimaldab: „/.../siin teenusel olles olen ma saanud iseseisvamaks.” Autonoomiana mõistetakse olukordi, kus inimene saab midagi teha või otsustada oma äranägemise järgi. Samuti tõmbasid intervjueritavad paralleeli autonoomia ja vabaduse vahele.

Selgus, et mõnikord teevad iseseisvumisele takistusi oma liigse kontrollimisega hoopis inimese lähedased: */.../, Väga palju on muutunud. Enne seda ma elasin vanematega ja kõiki töid, mis on majapidamistööd, söögivalmistamine, poes käimine, triikimine, koristamine, ema tegi. Tema kogu aeg sellega tegeles, lihtsalt oli nii. Muidugi mina ka midagi tegin, aga see oli nagu harjumus, et ema tegi. Aga siin ma kõik ise teen ja see on nii meeldiv.*

/.../, Noo... kogu aeg ma pidin vanematega rääkima, mis ma teen, kuhu ma lähen, kus ma käin. Praegu nad ka küsivad, kui ma käin neid külastamas ja muidugi ma räägin neile, et ma käin tööl ja nii. Nüüd on jah rohkem iseseisvust. Et ma lähen ise linna ja ma otsustan ise, mis ma teen.

Kompetentsus. Enda pädevana tundmine tekitab inimeses rahulolutunde, annab lisaenergiat uute asjade õppimiseks (Ryan ja Deci 2017). Kompetentsus hõlmab ka ise enda elu üle otsustamist ja valikute tegemist. Esimese asjana valib toetatud elamise teenusele suunatud inimene teenuseüksuse. Järgnevad isikliku tegevusplaani koostamine ja eesmärkide seadmine. Uurimistulemustest selgus, et klientide kompetentsusega arvestamine on teenuseüksuse eri-inev. Inimese soovidega arvestamine teenuse planeerimisel sõltub sageli tema varasemast käitumisest ja personali arusaamadest. On kohti, kus kõik elukondlikud otsused teeb klient ja personal on suunaja rollis: *„Kõik oma elukorraldust puudutavad otsused... ma teen ise. Aga ma*

kõik arutan siinsete töötajatega ja see toetus on mulle nii oluline. See on mulle nagu põhi, mille peale ma hakkan enesekindlamaks muutuma.”

On ka teenuseüksusi, kus kliendi elukorralduse üle otsustab keegi teine: /.../ „*ma saan hästi vähe valida, mida ma teen /.../ ma vähe otsustan oma asjade üle...*”.

Emotsionaalselt raskeim, mis osas vastajates siiani negatiivseid tundeid tekitab, oli seotud teenusele ja teenuseüksusesse suunamisega. Eriti paistis see välja hooldekodust toetatud elamisele suunatud klientide puhul. „*Ma ei saanud oma sõpradele isegi head aega öelda. Öeldi, et lähed teise kohta lihtsalt. Mul oli kaks kilekotti asju... siis toodi siia ja... no seal oli ikka parem ja no... siin on kõik võõras, kedagi ei tunne ja... seal oli ikka meil oma ülesanded ja me olime kõik koos või nii.*”

„*Mind viidi sinna. Seal ma olin viis aastat. Pärast viidi neljaks kuuks hooldekodusse, siis seal ma istusin neli kuud ja saadeti tagasi. Seal oli juhataja.... Seal me läksime temaga tülli ühesõnaga ja mind saadeti ära siia.*”

„*Mina ei ole valinud. Siia toodi ja tegi viha küll. Tahaks hea meelega ära minna.*”

Vastajad tundsid, et neid peetakse eba-kompetentseks nende tervist puudutavates küsimustes. Mitmed psüühikahäirega inimesed rääkisid hirmust, mida nad tundsid, kui neid oli vastu nende tahtmist hospitaliseeritud.

Mitmed vastajad kurtisid ka seda, et rahaga seonduvas on nende õigused piiratud. Piirangud olid seotud nende varasema käitumisega. Enamiku sedasi arvanute puhul (v.a enne hoolekandeesutuses elanud inimesed), oli tegu heausksete inimestega, kes jagasid oma sissetulekut tuttavatega või olid võtnud laenu, mida nad ei suutnud tagasi maksta: „*juhtus paar korda, et ma andsin inimestele raha, kes ei kavatsenudki*

seda mulle tagasi anda. Lõpuks tuli välja, et nad tahtsid minuga sõbraks saada ja kohtuda selleks, et minult lihtsalt raha saada. Praegu on nad politseis ja kõik see laheneb. Aga raha mul nüüd ei ole. Nüüd minu ema vastutab minu konto eest. Kas teile meeldiks see? Kellele meeldiks see? Siin on, millest mõelda.” Hoolekandeesutusest teenusele tulnud inimeste puhul kordus see, et nad käivad küll poes ja kasutavad pangakaarti ning sularaha, kuid nad ei oska täpselt öelda, kui suur on nende igakuine sissetulek ja millised on väljaminekud.

Seotus. Ryan ja Deci (2000) defineerivad seotust olukorrana, kus inimene tunneb kokkukuuluvust teistega või kogukonnaga, kus ta igapäevaselt füüsiliselt kohal on. O'Brieni (1993) kohaselt eeldab kogukond samuti füüsilist kohalolu. Selles kontekstis on inimesel õigus kaasa rääkida teenuse korralduses, kasutada avalikke teenuseid ja olla kaasatud kogukonda, mis teda ümbritseb. Uurimistulemused näitavad, et kaasamine teenusüksuse ellu ja tegemistesse erineb. Kahes kohas tegid kliendid kõik igapäevased otsused ise, tegevusjuhendaja oli suunaja rollis. Ühes üksuses olid korralduslikud otsused juba paika pandud. Kuigi vastajad olid kaasatud tegevuste planeerimisse, tajusid nad, et peavad pakutud tegevustest osa võtma: „*Varem oli siin palju gruppe. Ikkagi nii, et me peame käima. Meid keegi ei sunni, aga kuna need olid meie jaoks tehtud, siis me käime.*”

Kogukonnaga seotud piiranguid on kogenud enamik vastajaid: „*Piir tõmmatakse vahele, et on küla inimesed ja MTÜ inimesed. Ikka öeldakse, et näe, ta on ...*” Intervjueeritavad tõid välja, et neid on eemale tõrjutud kogukonna või avalikelt ühisüritustelt. Seetõttu ei ole toetatud eluaseme teenust kasutavad inimesed ka ise

aktiivsed kogukonda sulanduma, kuna neid kiputakse sildistama. Küsitletud tundsid ennast turvaliselt teenuseüksuses kui omas keskkonnas ja sealsete kaaslastega suheldes. Selline tendents soodustab eraldumist, mis sugugi ei järgi kogukondlike vaimse tervise teenuste põhimõtteid.

On rõõmustav, et kuigi teenused on erineva ülesehitusega, kaasatakse kliente teenuse planeerimisse järjest rohkem. Iga kliendi abivajadus on individuaalne ja ta vajab seetõttu personaalset lähenemist.

Kokkuvõte ja järeldused

Uuringu järgi hindavad kasutajad kõige kõrgemalt teenuse head mõju oma autonoomiale. Samas tuleb välja, et nad on kogenud mitmeid piiranguid, mis tulenevad kliendistaatusest ja puudutavad nende kompetentsust. Alati ei aktsepteerita nende enesemääramise ja iseseisva tegutsemise õigust, eriti puudutab see kaasarääkimist teenuseüksuse valikul, individuaalse tegevuskava koostamisel ning elukorraldust, nt tervist ja raha kasutamist hõlmavaid otsuseid.

Osa piiranguid on mõistetavad, kuid toetatud elamise teenuse juures peab rohkem arvestama klientide enesemääramise õigusega. Autonoomia, kompetentsuse ja seotuse kui kolme olulise psühholoogilise vajadusega arvestamine on eelduseks, et teenused muutuksid isikukesksmaks ja tulevikus saaksid kliendid liikuda väiksema toetusvajadusega teenusele või iseseisvasse ellu.

On rõõmustav, et kuigi teenused on erineva ülesehitusega, kaasatakse kliente teenuse planeerimisse järjest rohkem. Iga kliendi abivajadus on individuaalne ja ta vajab seetõttu personaalset lähenemist. N-ö gruppidegevused on küll sotsialiseerivad ja vajalikud, kuid peab silmas pidama, et inimesele ei ole otstarbekas pakkuda tegevusi, mis arendavad oskusi ja võimeid, mis on tal juba olemas. Klienti tuleb eelkõige aidata tegevustes, kus ta tegelikult tuge vajab. See aga eeldab kliendi kaasamist planeerimisse ja arvestamist tema kompetentsidega.

Et toetatud elamise teenust kasutavad inimesed ei tunneks end kogukonnast eraldatuna, tuleks luua kogukonnas rohkem võimalusi erinevate rühmade läbikäimiseks ja parandada teineteise mõistmist. Eriti oluline on kogukonna sotsiaaltöö arendamine kohalikes omavalitsustes, kus asuvad kogukondlike vaimse tervise teenuste üksused. **S**

Viidatud allikad

- Dixon R., Marsh W. H., Craven G. R.** (2004). Moving out: the impact of deinstitutionalisation on salient affective variables for people with mild intellectual disabilities.. Univesity of Wollongong Australia. Sydney, 1–12.
- European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care** (2012). Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care. <http://deinstitutionalisationguide.eu>. (22.11.2018).
- Landesman S., Butterfield E. C.** (1987). Normalization and Deinstitutionalization of Mentally Retarded Individuals: Controversy and Facts. *American Psychologist* 42 (8), 809–816.

- O'Brien J.** (1999). Community Engagement: A Necessary Condition for Self-Determination and Individual Funding. Responsive Systems Associates, Inc.
- Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon.** (2006). RT II, 04.04.2012, 6.
- Roos, E., Bjerkeset O., Svavarsdottir, M. H, Steinsbekk. A.** (2017). Like a hotel, but boring: users' experience with short-time community-based residential aftercare. BMC Health Services Research. DOI: 10.1186/s12913-017-2777-z.
- Ryan, M. R., Deci, L. E.** (2000). Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. *American Psychologist*. Vol.55, No.1, 68–78. DOI:10.1037//0003-066X.55.1.68.
- Ryan, M. R., Deci, L. E.** (2017). Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. NY. Guilford Press.
- Sotsiaalkindlustusamet.** (2018). Erihoolekandeteenused. www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused#Erihoolekandeteenused (22.11.2018).